Sujet n°1 : SDD 2 Diarrhée

Spécialité : Infectiologie

Date : 13/10/2023
Auteur : Ambroise LE POGAM (DES de médecine interne - ECN 2018)
Relecteur(s) : Sébastien VILLARD (DES de médecine interne - ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	176. Diarrhée aiguë infectieuse
Situation(s) de départ en lien avec la station	2. Diarrhée
Matériel nécessaire à la station	Bureau pour interrogatoire
Contexte de la station	Consultation aux urgences

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne de garde aux urgences.
M. Diallo Raymond consulte pour une diarrhée survenant depuis 48 heures.
C'est un patient de 76 ans, originaire du Mali, en France depuis 40 ans. Il est ancien fonctionnaire de police, il vit en appartement avec sa femme, a trois enfants, ne présente pas d'intoxication alcoolo-tabagique.

Ses antécédents sont : une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un diabète de type 2, une insuffisance rénale chronique avec un DFG à 50 mL/min/m² ainsi qu'un infarctus stenté il y a 10 ans. Pas d'antécédent familiaux notables.

Constantes : TA : 110/75 mmHg, Fc : 90 bpm, T° : 38°C, Sat 02 : 98% en AA, FR : 14/min EVA : 0/10

Examen clinique : sans particularité (pas de douleur abdominale, auscultation normale, pas d'adénopathie) mise à part un pli cutané marqué.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Interroger le patient à propos de ses symptômes pour orienter la prise en charge
- Proposer des examens paracliniques s'ils sont nécessaires
- Proposer la suite de la prise en charge thérapeutique : ambulatoire ou hospitalisation, traitements à initier

Vous ne devez pas :

- Examiner le patient
- Écrire la prescription des examens paracliniques
- Réaliser un interrogatoire complet

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Consistance des selles : sang et glaire	1 pt
2.	Recherche la fréquence des selles	1 pt
3.	Recherche une perte de poids	1 pt
4.	Recherche des nausées ou vomissements	1 pt
5.	Parmi les éléments suivants : ok si 2 - Prise d'antibiotiques - Voyage récent - Cas contact/dans la famille	1 pt
6.	Examen paraclinique : Coproculture	1 pt
7.	Examen paraclinique : Ionogramme sanguin OU Na+ et K+ et créatinémie et HCO3-	1 pt
8.	Thérapeutique : Hospitalisation	1 pt
9.	Thérapeutique : retrait des IEC	1 pt
10.	Antidiarrhéique : Racécadotril/Tiorfan (Imodium considéré faux □ 0)	1 pt
11.	Antibiotiques : C3G (Céfotaxime OU Ceftriaxone) OU Fluoroquinolone	1 pt
12.	Perfusion : NaCl 0,9%	1 pt
13.	Prescrit du paracétamol	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

TOTAL (max 20 items)	**15 points**

Éléments de rétroaction :

Les troubles du transit sont des motifs de consultation fréquents. Face à des diarrhées, il faut savoir discerner grâce à l'examen clinique et à l'interrogatoire le cadre étiologique de la diarrhée (cholériforme, gastro-entéritique, dysentérique) pour savoir quels examens réaliser :

- Coproculture : Sang ou glaires dans les selles/Syndrome dysentérique (toujours), cholériforme ou gastro-entéritique en cas de signe de gravité (selles >6/jours, fièvre > 38°C, hospitalisation), TIAC
- Virologie des selles : patients immunodéprimés ou contexte de TIAC
- Toxine A-B : antibiotiques dans les « derniers mois ou hospitalisation depuis 3 jours (diarrhée nosocomiale) ou diarrhée en institution avec bilan exploratoire de premier intention négatif
- Parasitologie des selles : en cas de retour de voyage dans l'année et chez l'immunodéprimé
- Hémoculture en cas de fièvre, NFS Ionogramme sanguin CRP en cas de terrain à risque de complication, diarrhée sévère ou répercussion clinique de la diarrhée

Les critères d'hospitalisation sont à connaître pour ne pas laisser rentrer chez lui un patient fragile, comorbide, déshydraté avec des diarrhées abondantes. Une déshydratation avec perte de >8% du poids corporel indique une hospitalisation (ici 10%).
Le pli cutanée, les selles abondantes et le contexte d'insuffisance rénale peuvent d'emblée orienter avant le résultat de la biologie vers une déshydratation (clinique) avec potentielle répercussion sur la fonction rénale sur un rein préalablement fragilisé (IRC) : une hydratation par NaCl 0,9% est conseillée. En principe hydratation de 50% des pertes totales les 6 premières heures puis les 50% du reste des pertes sur les 18H00 suivantes (en théorie ici 4L en 6H mais semble trop surtout chez insuffisant rénal). Cf. pilly
Contre-indication aux antidiarrhéiques bloquant la motricité intestinale comme le Lopéramide (Imodium) car haut risque de translocation et bactériémie, on préfèrera le Racécadotril.

L'antibiothérapie est indiquée (toujours après la coproculture si possible) en cas de syndrome dysentérique (tous), syndrome cholériforme et gastro-entéritique sévère. On préfèrera en cas de voie d'abord IV une Céphalosporine de 3ème génération (Céfotaxime ou Ceftriaxone) ou en per os quand réalisable de la Fluoroquinolone ou de l'Azithromycine.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Le patient consulte pour des diarrhées évoluant depuis 3 jours. Il a plusieurs comorbidités, a perdu du poids et présente du sang dans les selles.

Plan de la station ECOS :

Le patient se positionne à un bureau pour être interrogé par l'étudiant (ou bien de chaise l'une à côté de l'autre comme aux urgences)

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

« Bonjour Docteur, je viens aux urgences car depuis 3 jours j'ai des diarrhées très importantes et que je me sens fatigué. Au début je voulais pas trop venir mais ma femme m'y a encouragé donc bon je suis là … »

Identité du patient :

M. Diallo Raymond, 75 ans, Taille : 182 cm, Poids habituel : 80 kg, poids actuel : 72 kg

Mode de vie :

Agent de police à la retrait, vit avec sa femme en appartement, a trois enfants, ne fume pas ne boit pas, pas d'allergie, pas d'animaux. Originaire du Mali, il est en France depuis 40 ans et n'a pas voyagé en dehors de l'Europe depuis 10 ans.

Comportement global :

Relativement détaché, le patient vient surtout car sa femme lui a conseillé de venir, explique qu'il soit peu loquace sur ses symptômes spontanément. Pas anxieux outre mesure.

Antécédents personnels :

Hypertension artérielle
Hypercholestérolémie
Diabète de type 2
Insuffisance rénale chronique 50 mL/min
Infarctus stenté il y a 10 ans

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

Prise quotidienne/habituels :
Amlodipine 5 mg 1 cp le matin
Ramipril 5 mg 1 cp le matin
Atorvastatine 10 mg 1 cp le soir
Kardegic 75 mg 1 cp le matin

Prise occasionnelle de médicament :
Doliprane/Paracétamol 1 cp 4 fois par jour

Symptômes positifs :

Symptômes positifs (**uniquement si demandé**, sinon se tenir au script initial) :

Glaire dans les selles □ oui
Sang dans les selles □ oui
Premier épisode de diarrhée similaire □ oui
Nombre de selles par jour □ 8 à 10 fois à la selle
Perte de 8 kg depuis le début des diarrhées par rapport au poids de base (80 kg □ 72kg)

Symptômes négatifs (seront possiblement demandés par l'étudiant) :

Pas de diarrhée très liquide/aqueuse
Pas de prise d'antibiotiques récente
Pas de nausée/vomissement
Pas de douleur (abdominale ou ailleurs)
Pas de voyage récent
Pas d'autres personnes avec des diarrhées dans l'entourage
Pas de repas dans un restaurant
Pas de contact avec des petits-enfants/crèche/hôpital
Pas de prise de médicament ou naturopathie ou autre substance « rien à part du Doliprane »
A jour du dépistage du CCR
Pas d'anneaux de taenia dans les sousvêtements
Autres problèmes de santé récemment « à part l'infarctus il y a 10 ans et mes reins qui fonctionnent moins bien, non »

Constantes :

TA : 110/75 mmHg, Fc : 90 bpm, T° : 38°C, Sat02 : 98% en AA, FR : 14/min EVA : 0/10

Donnée complémentaire :

Aucun

Questions de relance :

Après 4 minutes si l'étudiant n'a pas évoqué la perte de poids ou le nombre de selle par jour, faire la remarque à haute voix : « C'est ma femme qui va être contente, depuis le temps qu'elle voulait que je fasse un régime … J'ai bien perdu ces trois derniers jours »

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Box de consultation des urgences : une table, deux chaises, étudiant et patient face à face pour l'interrogatoire.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours